

MONOGRAFIA DEL PRODUCTO

NEUFIL
jarabe

Broncodilatador

1. Nombre de la especialidad farmacéutica

Neufil

2. Composición cualitativa y cuantitativa

Diprofilina, 100 mg por 15 ml

3. Forma farmacéutica

Jarabe

4. Informaciones clínicas

4.1. Indicaciones terapéuticas

Tratamiento de enfermedades bronco pulmonares obstructivas: asma bronquial, bronquitis y enfisema.

4.2. Posología y modo de empleo

A establecer por el Médico según el caso. Todavía la posología recomendada es la siguiente:

Niños: 14 mg/Kg/día, en 3 ó 4 dosis parcelarias; 1 cuchara de las de té (5 ml) o de las de postre (10 ml) cada 6 ó 8 horas, según la edad.

Tomar el jarabe sólo o desleído con un poco de agua.

La dosis máxima no está aún establecida, pero no es necesario sobrepasar la dosis máxima diaria de 60 mg/Kg./diaria para el adulto, repartida por 4 tomas diarias.

La duración del tratamiento en las crisis agudas será de algunos días, tiempo suficiente para debelar los síntomas agudos; el tratamiento de manutención es más largo, ya que deberá mantenerse hasta la supresión estable de la sintomatología o hasta que el Médico decida cambiar la terapéutica.

4.3. Contraindicaciones

Epilepsia u otras síndromes convulsivantes. Hipersensibilidad conocida al medicamento.

4.4. Advertencias y precauciones especiales de empleo

Los niños son más sensibles que los adultos a los efectos indeseables de las metilxantinas, así que los intervalos entre las dosis parcelarias deben ser completamente cumplidos. Considerando que la diprofilina no es metabolizada por vía hepática, no es necesario tener las precauciones habitualmente recomendadas para la teofilina.

4.5. Interacciones medicamentosas y otras

La determinación de las concentraciones plasmáticas de diprofilina no es falsamente aumentada por la ingestión de bebidas con cafeína (café, té, chocolate) o por otros fármacos. El probenecid retrasa la eliminación de la diprofilina, lo que obliga a la reducción de las dosis. Los estimulantes adrenérgicos beta y otras metilxantinas ejercen un efecto broncodilatador y estimulante central aditivo cuando utilizados en simultáneo con la diprofilina. El probenecid y otros medicamentos que bloquean los procesos de secreción y reabsorción tubular reducen la velocidad de secreción activa y de excreción de la diprofilina, aumentando los valores de las concentraciones plasmáticas y la semivida de esas concentraciones. No se observan las interacciones características de la teofilina ligadas a la metabolización hepática de dicho fármaco.

4.6. Embarazo y lactancia

Aunque no estén descritos casos de toxicidad en la mujer embarazada, se recomienda por prudencia utilizar la diprofilina solamente cuando estrictamente indispensable. Lo mismo se aplica a las madres lactantes puesto que el medicamento pasa para la leche materna.

4.7. Efectos sobre la capacidad de conducción y utilización de máquinas

No tiene.

4.8. Efectos secundarios

Son poco frecuentes y de intensidad ligera. Todavía no puede excluirse la posibilidad de apareamiento de alguna sintomatología dispéptica, relacionada con el medicamento. También puede ocurrir, sobre todo con dosis elevadas en niños, fenómenos moderados de estimulación central. Los fenómenos de hipersensibilidad son, sobre todo, cutáneos y de muy rara incidencia.

Estos efectos suelen desaparecer al interrumpirse la medicación, pero en casi la totalidad de los casos no es necesario interrumpir la terapéutica.

4.9. Sobredosis

En casos de sobredosificación o intoxicación los primeros síntomas son vómitos, nerviosismo y agitación. En casos más graves, en enfermos particularmente sensibles, puede observarse confusión mental y convulsiones. El tratamiento es sintomático y no hay antídotos específicos.

5. Propiedades farmacológicas

5.1. Propiedades farmacodinámicas

Droga que actúa sobre el aparato respiratorio: antiasmático.

La diprofilina único componente activo de NEUFIL, es un derivado de la teofilina, la dihidroxipropilteofilina.

Sin embargo, la diprofilina es una sal de teofilina, no es metabolizada a teofilina, la diprofilina actúa por su propia molécula; el mecanismo de acción de la diprofilina al igual que teofilina ocurre por inhibición de la fosfodiesterasa, por lo que se aumenta la concentración intracelular de AMP cíclico, particularmente en las células musculares lisas y especialmente en las de los bronquios; esta acción se traduce en un efecto inhibidor del broncoespasmo, con aumento del flujo de aire y de la capacidad vital.

Aunque en grado menor, la diprofilina ejerce también otras acciones características de las metilxantinas (dilatación coronaria, diuresis, moderada estimulación cardíaca, cerebral y del músculo esquelético).

Sin embargo tras la administración de dosis terapéuticas, estas acciones no se traducen en reacciones adversas, con significancia clínica. Aún hay que señalar que la diprofilina a diferencia de la teofilina, puede provocar disminución del umbral para convulsiones, lo que contraindica en los pacientes epilépticos.

La eficacia y la buena tolerabilidad de la diprofilina están bien comprobadas por ensayos clínicos controlados.

El promedio de las respuestas terapéuticas favorables se sitúa en aproximadamente el 90%.

La tolerabilidad excelente de la diprofilina ha sido siempre comprobada, confirmando el perfil farmacodinámico diseñado por los ensayos en los animales de experiencia, en los cuáles la toxicidad aguda de la diprofilina es 5 veces más baja que la de la teofilina.

5.2. Propiedades farmacocinéticas

La presencia de un grupo hidrofílico dihidroxipropil confiere a la diprofilina una solubilidad en agua 40 veces más alta que la de la teofilina; las soluciones de diprofilina son neutras y su molécula es estable frente al ácido clorhídrico del estómago. El conjunto de estas características hace de la diprofilina una metilxantina broncodilatadora de gran interés terapéutico, por las consecuencias farmacocinéticas y de tolerabilidad que tales características implican (además de la prácticamente ausencia de estimulación central y del corazón). La diprofilina se absorbe muy bien por el tracto digestivo. La biodisponibilidad media es del 75% con pequeñas variaciones interindividuales. La vida media plasmática es de 2,1 horas tras la administración intravenosa. La distribución es muy amplia y rápida y el volumen medio de distribución es de 0,6 L/Kg. La metabolización de la diprofilina no está completamente conocida, pero se sabe que es poco intensa y que no hay transformación en teofilina. Después de una inyección intravenosa, se recuperan en la orina el 96% de la dosis administrada. La excreción es esencialmente urinaria; tras la administración oral se recupera en la orina el 72% de la dosis administrada.

6. Informaciones farmacéuticas

6.1. Lista de excipientes

Sacarosa, Etanol, Agua purificada, Nipasept, Aroma.

6.2. Incompatibilidades

Por falta de estudios de incompatibilidad, este medicamento no debe ser mezclado con otros.

6.3. Plazo de validez

5 años.

6.4. Precauciones especiales de conservación

Consérvese bien cerrado.

6.5. Naturaleza y contenido del envase

Flacón de vidrio conteniendo 200 ml jarabe, acondicionado en envase de cartulina.

6.6. Instrucciones de utilización y manipulación (y eliminación)

No existen requisitos especiales.

7. Titular de la Autorización de Introducción en el Mercado

BIAL – Portela & C^a, S.A.

À Av. da Siderurgia Nacional

4745-457 S. Mamede do Coronado -Portugal

8. Número de Autorización de Comercialización

4131-APG-1540

9. Fecha de la primera Autorización/Renovación de la Autorización

Fecha de la primera Autorización: 13/07/1992

Fecha de la última renovación de Autorización: 15/04/2016

10. Fecha de la revisión del Texto

04/2016

BIBLIOGRAFIA

1. Jain P, Golish JA. Clinical management of asthma in the 1990s: current therapy and new directions. *Drugs* 1996; 52 (Suppl 6): 1-11
2. Kidney J, Dominguez M, Taylor PM, Rose M, Chung KF, Barnes PJ. Immunomodulation by theophylline in asthma. *American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine* 1995; 151: 1907-1914
3. Lawyer CH, Bardana Jr EJ, Rodgers R, Gerber N. Utilization of intravenous dihydroxypropyl theophylline (dyphylline) in an aminophylline-sensitive patient, and its pharmacokinetic comparison with theophylline. *Journal of Allergy and Clinical Immunology* 1980; 65 (5): 353-357
4. Levine ER. An effective oral medication for long term bronchodilation. *Annals of Allergy* 1965; 23 (9): 403-413
5. Ouellette JJ, Kriz, RJ, Kooistra, JB. Efficacy and tolerability of dyphylline in bronchial asthma: a retrospective survey. *Current Therapeutic Research* 1980; 27 (6, Sec 1): 844-851
6. Scordamaglia A, Ciprandi G, Ruffoni S, Caria M, Paolieri F, Venuti D, Canonica GW. Theophylline and the immuno response: *in vitro* and *in vivo* effects. *Clinical Immunology and Immunopathology* 1988; 48: 238-246
7. Simons FER, Bierman CW, Sprenkle AC, Simons KJ. Efficacy of dyphylline (Dihydroxypropyltheophylline) in exercise-induced bronchospasm. *Pediatrics* 1975; 56 (Suppl): 916-918
8. Simons FER, Simons KJ, Bierman CW. The pharmacokinetics of dihydroxypropyltheophylline: a basis for rational therapy. *Journal of Allergy and Clinical Immunology* 1975; 56 (5): 347-355
9. Sullivan P, Bekir S, Jaffar Z, Page C, Jeffery P, Costello J. Anti-inflammatory effects of low-dose oral theophylline in atopic asthma. *The Lancet* 1994; 343: 1006-1008
10. Ward AJM, McKenniff M, Evans JM, Page CP, Costello JF. Theophylline – an immunomodulatory role in asthma? *American Review of Respiratory Diseases* 1993; 147: 518-523
11. Weinberger M, Hendeles L. Theophylline in asthma. *The New England Journal of Medicine* 1996; 334 (21): 1380-1388
12. Dyphylline. In USP DI – Drug Information for the Health Care Professional 1997, 17th ed., Vol.I, p. 1290-1292
13. Theophyllines. In American Hospital Formulary Service 2010, p. 3635-3641
14. Xanthines. In Martindale - The Extra Pharmacopoeia 1993, 30th ed., p. 1314-1327